# palliatieve sedatie

## Continue toediening

Continue palliatieve sedatie kan het best bereikt worden met midazolam (Dormicum®) middels een subcutaan infuus. Er wordt gebruik gemaakt van een stapsgewijze benadering:

### Stap 1

**Midazolam (Dormicum®)**
**Start** bolus 10 mg s.c. gevolgd door
**Onderhoudsdosering*** 1,5–2,5 mg/uur continu s.c./i.v.
Bij onvoldoende effect van onderhoudsdosering:

- na minimaal 2 uur nogmaals bolus 5 mg s.c. (dit kan iedere 2 uur herhaald worden onafhankelijk van de onderhouds - dosering).
- om de 4 uur de dosering met 50% ophogen, altijd in combinatie met een bolus van 5 mg s.c.

* Bij risicofactoren (patiënten > 60 jaar, gewicht < 60 kg, ernstige nier- of leverfunctiestoornissen, sterk verlaagd serumalbumine en/of co-medicatie die kan leiden tot versterkte sedatie):
- lagere onderhoudsdosering (0,5–1,5 mg/uur), en
- langer interval (6–8 uur) voordat de onderhoudsdosering wordt opgehoogd

Indien onderhoudsdosering > 20 mg/uur doorgaan naar stap 2.

### Stap 2

**Levomepromazine (Nozinan®)**
**Start** bolus 25 mg s.c./i.v, gevolgd door
**Onderhoudsdosering** 0,5–8 mg/uur s.c./i.v. in combinatie met midazolam. Zo nodig na 2 uur een bolus van 50 mg s.c. Cave irritatie van de huid. Na 3 dagen dosering i.v.m. stapeling halveren.
Bij onvoldoende effect midazolam en levomepromazine staken, doorgaan naar stap 3.

### Stap 3

**Propofol (Diprivan®)**
Alleen in ziekenhuis, onder supervisie van anesthesioloog.
**Start** bolus 20–50 mg i.v., gevolgd door
**Onderhoudsdosering** 20 mg/uur i.v.
Bij onvoldoende effect van onderhoudsdosering:
om de 15 minuten met 10 mg/uur ophogen.
Kan ook als stap 2 worden overwogen.

## Intermitterende toediening

Bij een zeer korte levensverwachting (< 24 uur), bij praktische problemen met de inzet van een pomp en bij kortdurende of intermitterende sedatie kan gekozen worden voor een andere wijze van toediening en/of andere middelen.

- **Midazolam (Dormicum®)**
  bolusinjecties,
  6 dd 5–10 mg s.c., (hierbij kan gebruik worden gemaakt van een verblijfsnaaldje),
  zo nodig ophogen in stappen van 50% per 4 uur,
  zo nodig kan na 2 uur een bolus van 5 mg s.c. extra worden gegeven

- **Diazepam (Valium®)**
  rectiole rectaal,
  10 mg elk uur tot voldoende sedatie is bereikt,
  gemiddeld 40–60 mg per 24 uur noodzakelijk

- **Lorazepam (Temesta®)**
  tabletten of injectievloeistof sublinguaal,
  1– 4 mg elke 4 uur

- **Clonazepam (Rivotril®)**
  druppelvloeistof sublinguaal,
  1– 2,5 mg elke 6 uur